

3 - 03- Contusions du globe oculaire + Brûlures oculaires - Pr. HAJJI

(0:01 - 3:15)

Alors bonjour tout le monde. Avant d'entamer le cours d'aujourd'hui, est-ce que vous avez des questions concernant les premières parties? Parce qu'aujourd'hui, ça sera la dernière séance concernant la traumatologie. On entame la séance d'aujourd'hui? C'est bon? Donc, on avait traité la traumatologie d'une façon générale.

On avait parlé des plaies du globe avec ou sans corps étranger. Aujourd'hui, on va traiter la partie contusion. Alors, la contusion, ça va concerner les traumatismes de l'œil, mais sans solution de continuité au niveau des parois.

Ça veut dire une contusion, mais on n'aura pas ni de plaies de cornéilles, ni de plaies de sclères. Contusion, ça veut dire un traumatisme qui est fermé. C'est bon? À l'extrême, qu'est-ce qu'on aura? Une explosion ou un éclatement de l'œil.

D'accord? Mais un traumatisme en dehors des éclatements de l'œil, on est dans les contusions de l'œil. Alors, les contusions sont très fréquentes. Les contusions, c'est les coups de gifle, c'est les traumatismes par les ballons.

Ils sont extrêmement fréquents, les contusions. C'est les traumatismes d'une façon générale, les jeux d'enfants, les agressions, les accidents domestiques, la violence, les traumatismes des alcooliques, des drogués, les traumatismes au cours de sport, également dans les accidents de circulation. Donc, l'œil va rester fermé et l'onde de choc va concerner toute la paroi et toutes les structures de l'œil seront concernées par le traumatisme.

Alors, je vous rappelle, au cours des plaies de l'œil, quand on a une plaie de cornéille, par exemple, uniquement la cornéille, un coup de couteau, par exemple, qui a touché la cornéille, uniquement la cornéille qui sera touchée. Je ne parle pas d'une plaie de cornéille qui a touché le cristallin, par exemple. D'accord? Alors, dans la contusion, tout l'œil est concerné par l'onde de choc.

On va voir comment ça va se passer. Alors, l'interrogatoire, comme toute la traumatologie, c'est l'identité du patient. Toujours vérifier l'identité du patient, l'âge de traumatiser.

L'enfant n'est pas comme l'adulte. Le terrain. Le terrain, de façon générale, est-ce que c'est un patient qui est fragile sur le plan général et est-ce que c'est un œil qui est fragile? L'œil fragile, c'est-à-dire, quels sont les terrains fragiles? Pas tous les miottes, mais les miottes fortes, les miottes les plus fortes.

Quoi d'autre? C'est pas un terrain fragile, c'est un terrain particulier, mais pas fragile. Quoi

d'autre? Les yeux opérés, les yeux uniques. Alors, est-ce que ça s'agit d'un traumatisme oculaire, traumatisme de l'œil ou c'est un polytraumatisé? Je ne cesse de le répéter.

(3:16 - 7:07)

L'agent entendant, c'est-à-dire l'agent traumatisant, il faut préciser la vitesse, la taille et la violence. La taille, pourquoi? Parce qu'un traumatisme par une petite pierre n'est pas la même chose par rapport à un traumatisme par un bal de foot, par exemple. Pourquoi? Parce que quand l'agent entendant est énorme, le traumatisme va être freiné par la paroi de l'orbite et l'œil est protégé grâce aux orbitaires.

Alors, quand l'agent traumatisant est petit, donc le traumatisme oculaire est indirect, d'accord? La symptomatologie, le patient se plaint de quoi? D'une rougeur, d'une baisse de l'acuité visuelle, d'une douleur, d'un larmement. Il faut savoir écouter le patient et la mesure de l'acuité visuelle, toujours systématique, de loin et de près, œil par œil, avec et sans correction. Alors, vous voyez ici un traumatisme par un objet qui est supérieur à la taille du cadre orbitaire et vous voyez que le cadre orbitaire, il va protéger l'œil.

Alors, si vous imaginez que si vous avez une petite pierre ou quelque chose comme ça, l'agent traumatisant entendant est petit, donc le traumatisme va être direct au niveau de l'œil. Toujours systématiquement, on va commencer par l'examen des annexes et de l'orbite. Alors, si l'agent entendant est énorme, pour arriver à l'œil, il faut fracturer l'orbite.

Vous imaginez quand on a une paroi de l'orbite qui est fracturée, déjà on a une idée sur la violence du traumatisme. Un traumatisme, un accident de circulation, un coup de bâton qui va donner une fracture de l'os frontal ou de la maxillaire, ou qui va donner une contusion de l'œil. Déjà, l'agent traumatisant est énorme.

Donc, il cherche un œdème, un hématome, fracture toujours palpée des parois orbitaires. D'accord? Alors, on a déjà fait la dernière fois la palpation du cadre orbitaire, toujours continuité et on a une partie qui est sensible ici, petite marche ici, qui est sensible, c'est quoi? C'est la polie. L'oblique supérieur est palpé ici et vous allez trouver une petite écorchure ici qui est sensible, qui est la polie de l'oblique supérieur.

D'accord? À part ça, on a une continuité et ce n'est pas douloureux. Quand on a une douleur exquise à la palpation orbitaire, on a une marche, un décalage, ça veut dire qu'il y a une fracture de paroi orbitaire. Cherchez une exophtalmie.

L'exophtalmie peut être expliquée par quoi? Dans un contexte traumatique, un hématome. Cherchez la position de l'œil. Il peut être où l'œil? Situé un petit peu plus bas.

Quand est-ce qu'il peut être situé plus bas? Fracture de plancher, parfois à l'extrême, il peut être où? Carrément dans le sinus. D'accord? Quand on a un effondrement du sinus de plancher de

l'orbite, donc position de l'œil, soit elle est plus bas, soit à l'extérieur dans le cadre d'une exophtalmie. Toujours étudier la motilité oculaire et chercher une plaie.

L'examen de l'œil proprement dit. Donc on va commencer par l'examen de la cornée. Le test de la fléurie séine, il est très important parce qu'il faut chercher des écorchures, des ulcérations et ici dans le cadre d'une contusion, éliminer une plaie de l'œil.

(7:08 - 9:31)

D'accord? Test de la fléurie séine, comment on le fait? Ça donne quoi le test de la fléurie séine dans le cadre d'une plaie de l'œil? C'est quoi? C'est le test de? Le test d'elle, comment on fait? On met une goutte de la fléurie séine et on expose, c'est écrit sur la première partie, la lumière bleue cobalte. D'habitude, on a une lumière qui est homogène, mais si jamais on a une plaie de l'œil, l'humeur aqueuse va sortir, il va laver la fléurie séine. Cette coulée de l'humeur aqueuse signifie qu'il y a une plaie qui est sortie de l'humeur aqueuse, on va appeler ça un CDL positif, c'est un signe indirect d'une plaie de l'œil.

Dans le cadre de la contusion, la fléurie séine va nous donner une idée, est-ce qu'il y a une érosion? Est-ce qu'il y a une ulcération, un ulcère? Et dans le cadre de l'examen de la cornée, il faut chercher, est-ce qu'il n'y a pas un œdème de cornée? Est-ce qu'il n'y a pas un hématocone? L'hématocone va venir d'où? C'est une complication de quoi? Complication de quoi? C'est quoi l'hématocone? C'est quoi l'hématocone? C'est une infiltration stromale par du sang. C'est une complication de quoi? C'est quoi? C'est un nifflément total prolongé ou associé à une hypertension. Et l'nifflément total, c'est une complication classique d'une contusion grave.

Cherchez, lors d'un examen de la conjonctive, une hémorragie sous-conjonctivale, une hyperémie, une érosion, un chémosis hémorragique. Alors, le chémosis hémorragique, c'est un signe qui peut être associé à quoi? Une plaie sclère. Il peut être, ce n'est pas un signe pathognomonique, mais devant un chémosis hémorragique, éliminer une plaie sclère.

(9:33 - 10:33)

Alors, l'examen de chambre antérieure, toujours évaluer la profondeur, y a-t-il un collant, diminuer ou augmenter la profondeur? Est-ce que cette profondeur est homogène ou irrégulière? Si elle est irrégulière, c'est un signe indirect d'une subluxation du cristallin. Et le contenu, dans un contexte traumatique, il peut s'agir d'un tendal hémattique ou carrément d'un nifflément qu'il faut savoir stadifier. Un nifflément stade 1, ça veut dire le quart de la profondeur.

Nifflément stade 2, c'est la moitié. Trois quarts, c'est le stade 3. Nifflément total, c'est la totalité. Examen de l'iris, chercher l'iridodialyse.

C'est quoi l'iridodialyse? Un arrachement de l'iris depuis son insertion. Une rupture de sphincter de l'iris, c'est quoi? C'est un patient qui reste dilaté. Le sphincter est complètement détruit.

(10:34 - 10:55)

Les ruptures de sphincter de l'iris, c'est un signe de gravité du traumatisme. Parmi les signes de gravité d'un traumatisme du contusion, la rupture du sphincter de l'iris qui va donner midriase post-traumatique. Le sphincter ne fonctionne plus, il est détruit.

(11:03 - 11:27)

Même l'iridodialyse est un signe de gravité. Le cristallin, est-ce qu'il est clair? Est-ce qu'il est cataracté? Il y a un type de cataracte qui est pathogonique d'une contusion. On peut chercher une subluxation.

(11:27 - 11:41)

Tout à l'heure, on avait parlé d'une irrégularité de profondeur de chambre antérieure qui est un signe indirect d'une subluxation. Il y a un autre signe, ce qu'on appelle un iridodonsis. Donsis, ça veut dire danser.

(11:42 - 12:01)

Un cristallin qui va danser, on va demander au patient de regarder vers le haut, vers le bas, à droite, à gauche. Et le cristallin qui est normalement bien soutenu par la zone nulle, il va commencer à trembler. Le tremblement signifie que la zone nulle est cassée quelque part.

(12:01 - 12:29)

Ce tremblement, c'est un signe de subluxation. Subluxation du cristallin, c'est un signe de gravité d'une contusion. Quand je vous ai dit que la contusion est fréquente, par exemple, un coup de poing, un jeu d'enfant, un match de foot, jusqu'à un coup de bâton.

(12:31 - 12:46)

Un traumatisme, une agression des alcooliques. Donc tout ça, ça peut être des agressions des contusions qui sont bénignes, jusqu'aux contusions qui sont très graves. Il faut savoir identifier tout ce qui est bénin, tout ce qui est très grave.

(12:47 - 12:59)

Alors la subluxation peut avoir comme signe un iridodonsis. L'iridonsis, ça veut dire tremblement. On va demander au patient de faire mobiliser son oeil vers le haut, vers le bas, à droite, à gauche.

(13:00 - 13:21)

Et quand il va regarder droit devant, on va sentir que le cristallin va trembler. Tremblement du

cristallin, c'est-à-dire que la zone nulle est cassée quelque part. En plus du tremblement du cristallin, à travers une petite brèche, soit nasale, temporal, supérieure, on peut avoir une petite mèche du vitre qui va passer à travers cette ouverture.

(13:21 - 13:49)

Pas un signe qui est fréquent, mais on peut l'avoir. Carrément, le cristallin peut soit se luxer vers l'avant, quand on a une rupture qui est très importante, va venir vers l'avant et ce sera une luxation antérieure, ou carrément partir vers l'arrière, ce sera une luxation postérieure du cristallin. Vous imaginez tout ça, ça témoigne d'une gravité du tremblement.

(13:51 - 14:05)

Alors la subluxation, c'est un déplacement dans un sens qui est frontal. Donc le cristallin, il est toujours frontal, mais il bouge un petit peu. Luxation antérieure et postérieure, c'est un déplacement qui est antéro-postérieur.

(14:07 - 14:28)

Ça va, vous me suivez? Et on peut avoir un cataracte conclusive. Les signes de gravité et d'eau, à quel point ils sont simples? Les signes de gravité d'une confusion, la subluxation, c'est un signe de gravité. Un traumatisme qui va éclater une zone nulle, c'est un signe de gravité.

(14:29 - 14:38)

Un lymphéma total, c'est un signe de gravité. Un éclatement du sphincter, c'est un signe de gravité. Un traumatisme bénin, c'est un traumatisme bénin.

(14:41 - 15:03)

Peut-être le patient va avoir un larmement, une gêne, mais le lendemain, le patient n'aura rien. D'accord? Il est dérangé, mais un ou deux jours plus tard, il n'aura rien. D'accord? Vous me suivez? Mais un traumatisme violent, c'est un traumatisme qui est violent.

(15:04 - 15:13)

C'est très important d'identifier tout ça parce qu'il y a beaucoup de patients qui réclament des certificats. Un certificat médico-légal. Tout ça, il faut le noter.

(15:14 - 15:30)

Alors l'hypertonie oculaire, ça témoigne d'une violence extrême. Alors l'hypertonie, il vient d'où? Beaucoup de mécanismes. Un traumatisme de l'ongle iridocorné, le cristal, et d'autres.

(15:30 - 15:46)

Tout ça peut donner une hypertonie oculaire. Alors par la suite, si vous avez des questions, vous m'arrêtez. D'accord? Vous me suivez pour l'instant? Ça va? Alors le segment postérieur.

(15:46 - 15:51)

Donc on va passer en rétro-cristallinière. À l'extrême. L'extrême.

(15:51 - 16:03)

L'extrême guerre, c'est l'éclatement de l'œil. Vous me suivez? L'extrême, c'est éclater l'œil. Alors l'extrême, mais on reste dans un plan qui est fermé.

(16:04 - 16:11)

On n'a pas éclaté l'œil. Mais l'œil, il est toujours fermé. L'extrême, sans avoir éclaté l'œil, c'est l'arrêt de la circulation.

(16:12 - 16:20)

On a un coup de poing. Arrêt circulatoire. D'accord? L'arrêt circulatoire, au niveau rétinien, ça s'appelle un œdème de Berlin.

(16:22 - 16:34)

On a un traumatisme très violent. Vraiment très violent. En conséquence, on aura un arrêt de la circulation de l'artère centrale de la rétine.

(16:34 - 16:39)

Vous imaginez la violence. Et ça existe. On en voit de temps en temps.

(16:41 - 16:52)

Alors cet arrêt circulatoire, qu'est-ce qu'il va occasionner? L'artère centrale de la rétine, elle va arrêter de fonctionner. Plus de sang. Qu'est-ce qu'on aura en conséquence? C'est l'artère centrale quand même.

(16:53 - 17:07)

Comme toutes les artères. Qu'est-ce qui irrigue l'artère centrale de la rétine? Une situation. Et l'irrigue la rétine interne.

(17:07 - 17:21)

Il y a deux systèmes circulatoires. Il y a la rétine interne et la rétine externe. La rétine interne, elle dépend de l'artère centrale de la rétine.

(17:21 - 17:42)

Et le retour veineux se fait à travers la veine centrale de la rétine. Et la rétine externe, elle dépend de la choroïde à travers le capillaire. Au niveau du centre de la macula, il n'y a pas de rétine interne.

(17:42 - 17:48)

On n'a que la rétine externe. Au niveau du centre de la fovéa, il n'y a que la rétine externe. On n'a que la choroïde capillaire.

(17:49 - 18:13)

Qu'est-ce qui se passe quand on a un arrêt circulatoire rétinéal? Toute la rétine est ischémique. L'ischémie, la rétine normale, elle est de quelle coloration? Orangée, rosée, puisqu'elle est vascularisée, c'est du sang. Alors l'arrêt circulatoire, qu'est-ce qu'il aura en conséquence? Blanche, terme, comme un cadavre.

(18:14 - 18:21)

C'est un arrêt circulatoire artériel. C'est comme un cadavre. C'est une rétine qui est en arrêt circulatoire.

(18:23 - 18:36)

Alors toute la rétine, elle est blanche, c'est une coloration de terme. Blanche, mais qui n'est pas vraiment blanche. C'est une coloration de la mort.

(18:37 - 18:51)

Alors toute la rétine, elle est blanche. Ce qui reste vascularisé, c'est la rétine externe, qui est visible au niveau du centre. Au centre, il n'y a pas de rétine interne, il n'y a que la rétine externe et qui dépend de la choroïde capillaire qui est toujours vascularisée.

(18:52 - 19:09)

Alors on aura une rétine qui est blanche. Au centre, on voit une rétine qui est vascularisée à travers une choroïde capillaire. Qu'est-ce qui se passe quand on a un arrêt circulatoire? On va parler de la macula.

(19:10 - 19:21)

La macula est une rose. Oui ou non? Parce que la différence, ou un contraste flagrant. Qu'est-ce qu'on va appeler la macula? On va appeler la macula rouge-cerise.

(19:21 - 19:37)

C'est pas une rose normale, c'est une macula rouge-cerise. C'est pas une cerise. La macula rouge-cerise est un signe scientifique qui témoignent d'une ischémie de l'œdème de Berlin.

(19:38 - 19:57)

C'est un signe de gravité. On trouve un macula gauche cerise, ça veut dire que la macula rétine est en arrêt circulatoire de l'artère centrale de la rétine. Vous avez compris les mécanismes ? L'artère centrale de la rétine n'est pas vasculaire, elle ne fonctionne plus, tout est blanc.

(19:57 - 20:08)

Il y a la courbure capillaire, qui est visible au niveau du centre. Au niveau du centre, rien n'a changé. La coloration est normale, mais le contraste est énorme, parce que tout autour est blanc.

(20:10 - 20:20)

La coloration rouge, ou la rosa, c'est normal, nous paraît plus prononcée, puisque tout autour est blanc. On appelle ça rouge cerise. Comme une cerise.

(20:24 - 20:39)

On appelle ça macula rouge cerise. Quand on voit une macula rouge cerise, c'est un signe de gravité, parce que tout autour est blanc. L'œdème de Berlin, c'est le stade extrême de traumatisme, fermé.

(20:40 - 20:57)

Quel pronostic pour ce patient ? On ne peut pas le dire. On ne peut pas le dire. Tout dépend de quoi ? Est-ce que l'artère centrale de la rétine va refonctionner ou pas ? On a essayé les corticoïdes, il y a des personnes qui n'ont pas essayé les corticoïdes.

(20:57 - 21:13)

Tout dépend, est-ce que l'artère va redémarrer ou pas ? Et on va dire au patient, le traumatisme est extrêmement violent, et vous avez du 57. Il y a des patients, chez qui, ça marchait. Ils ont récupéré une acuité.

(21:15 - 21:28)

La plupart des patients, chez qui, j'ai vu de l'œdème de Berlin, tout le monde les ont récupérés. Vous imaginez, c'est comme l'équivalent, c'est comme une coronaire. Vous avez une artère mésentérique, vous avez une artère cérébrale.

(21:29 - 22:03)

L'artère centrale de la rétine, d'accord, ça va, mais j'ai du traumatisme. Vous dites au patient, est-ce que je vais voir ? Oui, le traumatisme est violent, on va voir. Est-ce que vous pouvez pas lui dire que le pronostic est franchement très réservé ? Quand je vous dis, l'œdème de Berlin, est-ce que c'est un élément de mauvais pronostic ? Oui ou non ? C'est l'artère centrale de la rétine qui a arrêté de fonctionner.

(22:08 - 22:24)

Vous imaginez qu'un traumatisme qui a fermé une occlusion de l'artère ? va se déplacer. C'est ce que je veux dire. Je ne veux pas dire que ça se déplace.

(22:26 - 22:33)

C'est un élément de mauvais pronostic. C'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux.

(22:34 - 22:49)

L'œdème de Berlin ne peut pas fonctionner. Nous avons encore le délai d'éclatement. L'extrême d'une contusion en dehors d'un éclatement, c'est le deuxième débarré, ça fait.

(22:51 - 23:05)

Alors, on a d'autres complications du pôle postérieur, une hémorragie intravitréenne aussi, les mécanismes sont multiples. Exemple, un arrachement d'un vaisseau. Un autre exemple, un décollement postérieur du vitré.

(23:05 - 23:21)

Le vitré, on avait dit qu'il y a des adhérences intimes entre le vitré et la rétine. Il y a des zones de fortes adhérences également au niveau des arcades. Au cours d'un traumatisme, le traumatisme va créer un décollement postérieur du vitré.

(23:22 - 23:35)

Normalement physiologique à partir de 40 ans. Qu'est-ce que c'est le décollement postérieur du vitré ? C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'adhérences intimes entre le vitré et la rétine. C'est le décollement postérieur du vitré.

(23:36 - 23:52)

Tout le monde va le faire, mais la contusion va accélérer ce processus et le patient va le faire plus tôt. Alors si jamais il va faire un processus de décollement postérieur du vitré, il va le faire au niveau de l'arcade d'un vaisseau, il va arracher le vaisseau. Il va donner une hémorragie du vitré.

(23:53 - 24:02)

Il y a une cause pour laquelle il va faire l'hémorragie intravitréenne. En plus, il peut faire une déchirure rétinienne. Il va arracher, il peut arracher la rétine.

(24:03 - 24:16)

C'est un traumatisme qui a créé la déchirure. La complication de la déchirure, il va faire un décollement de rétine. Le décollement de rétine et la déchirure, c'est l'extrême urgence du segment postérieur.

(24:18 - 24:30)

Aussi, il peut créer une rupture de la courbure. Une contusion, il peut créer une scission au niveau de la courbure. Tout ça, c'est la violence du traumatisme.

(24:30 - 24:39)

Un coup de bâton peut avoir un éclatement. Il y a des patients chez qui il n'a pas eu un éclatement. Il peut avoir des mini-éclatements à l'intérieur de l'œil.

(24:40 - 24:48)

Il n'a pas éclaté l'asclère, mais il a éclaté la courbure. La courbure, c'est comme une éponge. L'asclère reste intacte, c'est la couche la plus résistante.

(24:49 - 25:00)

Mais on peut avoir des ruptures à l'intérieur de la courbure. Des couches de la rétine qui peuvent avoir des arrachements au niveau de la rétine. Seule l'asclère peut résister parfois.

(25:02 - 25:32)

Ça va ? Alors, ça va ? Je peux continuer ? Ça se complique ? À l'extrême, on avait dit, c'est l'éclatement de l'œil. Des rappels. Alors, c'est quoi ça sur la courbure ? Vous êtes habitués de la courbure.

(25:33 - 25:57)

C'est quoi ? C'est quoi l'IFEMA ? C'est quoi ? Présence de sang dans la chambre antérieure. Alors, comment on va spécifier l'IFEMA ? Stade 1. Stade 1, c'est un quart de la profondeur de la chambre antérieure. Stade 2, c'est la moitié.

(25:57 - 26:10)

Donc, on va se dire ici, c'est un quart de la chambre antérieure. Donc, stade 1. Stade 1, le

traitement diélu, c'est le repos strict et les boissons abondantes. Quand on voit un patient avec un IFEMA stade 1, il n'y a pas de traitement particulier.

(26:11 - 26:19)

C'est le repos strict. Le repos pour éviter qu'il va ressaigner. Et les boissons abondantes, c'est de liquifier le sang.

(26:19 - 26:36)

Comme ça, il va le drainer spontanément à travers l'ongle iride cornea. Alors, au bout de 1 à 2 jours, 3 jours, l'IFEMA peut disparaître complètement. D'accord ? Donc, l'IFEMA stade 1, très bon pronostic, et la guérison spontanément favorable.

(26:36 - 27:03)

D'accord ? Vous me suivez ? Ici. Est-ce que c'est comme ça qu'elle dit ? Elle dit question pour un champion. Qui peut commencer ? C'est compliqué.

(27:04 - 28:02)

Mais qui peut commencer ? Qu'est-ce qu'on voit ? Qui peut commencer ? Une question de quoi ? Une question de quoi ? Parlez en discutant, les idées vont venir. Qui peut commencer ? Qu'est-ce que vous voyez ? Rétine ? Oui. Les idées vont venir.

(28:09 - 28:29)

Pourquoi tu parles de chambre antérieure ? Alors, le cristallin, c'est où ? C'est ça ? C'est le cristallin. Donc, on est déjà dans le segment antérieur. Je ne peux pas te dire, mais il n'est pas du sang antérieur.

(28:30 - 28:36)

C'est le cristallin. Ça, c'est l'équateur. Déjà, on est dans le segment antérieur.

(28:37 - 28:43)

Ça, c'est le cristallin. Il est là. Ça, c'est le cristallin.

(28:45 - 28:54)

Ça, c'est le lend. Ça, c'est le lend. Le cristallin, c'est ça ? Les repères anatomiques, le cristallin avec le lend.

(28:57 - 29:17)

La distance entre le cristallin et le lend, c'est une distance par rapport aux deux côtés. Alors, regardez. C'est ça ? Le cristallin, c'est ça ? Ce qu'on voit du cristallin, ça veut dire quoi ? C'est une subluxation.

(29:17 - 29:32)

Elle est dans un plan qui est frontal. C'est bon. Qu'est-ce que vous voyez ? Oui.

(29:39 - 29:56)

Oui. Est-ce qu'il est là ? Oui. Qu'est-ce que tu ? L'iris, c'est ça ? Et la pupille, elle est là.

(30:02 - 30:26)

L'iris. Ça va ? En parlant ? Vous parlez ? Je reprends. Ça, c'est la sclère.

(30:32 - 30:39)

Et ça, c'est soi-disant la cornée. Et ça, c'est le lend. Ça, c'est le lend.

(30:39 - 30:48)

C'est la jonction entre la cornée et la sclère. Pour l'instant, vous me suivez. Le cristallin, c'est ça ? Ce qu'on voit du cristallin.

(30:48 - 30:56)

Ça, c'est ça. Je ne peux pas vous dire où est-ce qu'il est. D'accord ? Vous me suivez.

(30:57 - 31:09)

Normalement, la distance par rapport au lend, elle est la même partout. Donc si je dois avoir la même distance, je dois avoir la même ici et la même ici. Chose qui n'est pas valide.

(31:09 - 31:18)

Donc, on a une subluxation de ce côté. Pour l'instant, vous me suivez. Vous êtes d'accord que c'est une subluxation du cristallin ? Oui, puisqu'on est dans un plan différent.

(31:20 - 31:40)

L'iris, dans ce cas, il existe un arrachement de l'iris. L'iris, l'insertion irienne, ce qu'on doit faire, nous, prendre l'iris et l'insérer ici. Donc vous imaginez, on va tirer ça et l'insérer ici.

(31:40 - 31:58)

Et la pipi, il est ici. La pipi, elle doit venir ici. Vous me suivez maintenant ? Alors c'est une

chirurgie de réinsertion irienne pour reformer l'iris et chirurgie de cristallin subluxé.

(32:01 - 32:44)

Ça va ? Le sphincter de l'iris ? Le sphincter de l'iris, ouais. Il est rond, il est régulier. Le sphincter, il est bien.

(32:51 - 33:05)

La pipi, la pipi c'est le sphincter. Il est bon, il est régulier. Quoi ? Arrachement de la racine de l'iris.

(33:10 - 34:02)

C'est l'arrachement de la racine de l'iris. Ça c'est des arrachements plus petits. D'accord vous suivez? Mais la pèpite elle est bonne! C'est quoi? Oui, elle lèche subluxation du cristal, parce que c'est un déplacement dans un sens frontal.

(34:03 - 34:21)

Alors subluxation temporale, supérieure, inférieure, il faut l'identifier. C'est une subluxation inférieure du cristal, d'accord? Là, on met une mètisse. Le cristal est transparent.

(34:23 - 34:56)

Donc subluxation d'un cristal inférieur d'un cristal cataracté. Ou la subluxation inférieure d'un cataracte, d'accord? Il y a un cataracte, mais il n'y a pas de cataracte, d'accord? Qu'est-ce que c'est encore? Parce qu'il y a une mètisse. Alors c'est une subluxation inférieure d'un cataracte, d'accord? Pourquoi est-ce qu'on dilate le patient? Pourquoi est-ce qu'on dilate le patient? Parce qu'on l'a dilaté pour l'examiner.

(34:59 - 35:08)

On dilate le patient. Tu le sais. Pourquoi est-ce qu'on l'a dilaté? Pourquoi est-ce qu'on l'a dilaté? Parce qu'on dilate le patient.

(35:10 - 35:35)

Donc avant de juger le sphincter, est-ce que le patient est dilaté? Tu m'as compris? Avant de juger le patient, est-ce que le patient est dilaté? D'accord? Pour examiner un cristal, on dilate le patient. Le cristal est rétro-irien. On ne peut pas juger un cristal rétro-irien si on ne le dilate pas.

(35:37 - 35:54)

D'accord? Mais en absence d'une dilatation, il n'est qu'un spontanément comme ça, alors qu'il y a un problème. D'accord? Il n'est qu'un spontanément comme ça, il y a un problème. Parce que le

patient ne peut pas être dilaté à l'état naturel.

(35:54 - 36:10)

Ça fait? C'est bon. Vous êtes d'accord? Ensuite? Alors. Il y a quelqu'un qui dit quelque chose.

(36:12 - 36:28)

Je ne vais pas le dire. Oui? Il y a quelqu'un qui dit qu'il y a de l'excitation antérieure du cristal. Oui.

(36:29 - 36:35)

C'est ça. Ça c'est le cristal. Vous ne voyez pas la pupille? Bien sûr.

(36:36 - 36:52)

Le cristal est déjà en avant de l'iris. Parait-il qu'il est transparent? On ne peut pas être mais il est transparent. C'est une l'excitation antérieure du cristal hein? L'excitation antérieure du cristal elle est très urgente.

(36:52 - 37:14)

On le gère dans l'immédiat. Ça fait? L'excitation postérieure du cristal là, généralement il y a une urgence, généralement elle se fait à froid, deux urgences sur l'excitation postérieure, il y a l'hypertonie, l'intégralement de l'excitation antérieure toujours urgente. Ça fait? Alors.

(37:16 - 37:26)

C'est la seule cataracte. Il est d'origine traumatique. J'ai un patient et deux cataractes.

(37:26 - 38:14)

C'est la cataracte. Il peut être d'origine sémile, d'origine traumatique, d'origine diabétique, d'origine d'alzheimer, les seules formes de cataractes traumatiques un certain âge certifié totale à son âge ou la liée à son diabète, mais les seules formes de cataractes chacun on peut être sûr qu'il est d'origine traumatique il ne peut pas être sémile, il ne peut pas être diabétique, d'accord? C'est la seule forme. Alors on la voit extrêmement rare.

(38:15 - 38:30)

Mais si on la trouve, elle est en faveur d'un certifié C'est l'âge de la cataracte. C'est l'âge de la cataracte. Il ne peut pas être formel, le traumatisme qu'il a au cas où il a la cataracte.

(38:30 - 39:07)

D'accord? Ici, l'hernie l'hernie l'hernie est où? C'est la rupture du sphincter. C'est la rupture du sphincter. C'est le sphincter.

(39:07 - 39:25)

D'accord? Où est le sphincter? Où se situe le sphincter? Au niveau du pipi? Il est là. Il est là. Le bord.

(39:25 - 40:20)

Alors, si on suit le sphincter, il est là. Alors d'ici à ici, c'est quoi? La rupture. D'accord? Qu'est-ce qu'on pique la vie c'est quoi? C'est une cataracte totale.

(40:23 - 40:44)

Qu'est-ce qu'on pique la vie? C'est une cataracte totale blanche. Alors ici c'est quoi? Décollement de rétine. Quand est-ce qu'on va faire l'échographie? Si on a un trouble de milieu.

(40:46 - 40:55)

La rétine elle s'examine à la lampe à fente. Et si on a un trouble de milieu, je vois les troubles de milieu. Un niféma, une cataracte, un hemorrhagie des épreuves.

(40:56 - 41:04)

C'est-à-dire qu'on ne passe pas pour examiner la rétine. On fait une échographie. L'asthète témoigne d'un décollement qui est assez ancien.

(41:05 - 41:33)

Un décollement en V. La rétine elle est épaisse et rigide. C'est quoi? C'est une cataracte totale blanche. C'est quoi? C'est quoi? La rétine là.

(41:36 - 42:34)

Vous m'avez dit la rupture de la choroïde. Alors à la rupture de la choroïde, il est en dehors de la macula ou la région interpapillomaculaire ils sont sans conséquence sur la vision, d'accord? Alors la malchance il y a pour des personnes qui ont de la macula ou de la région interpapillomaculaire. Pourquoi est-ce qu'on peut avoir des douleurs dans la macula? Parce que si quelqu'un a eu le traumatisme, Si quelqu'un a eu le traumatisme, le traumatisme, il voit les gens qui l'ont frappé, les gens qui l'ont frappé, donc la macula que tu vois, il est fixé sur l'objet.

(42:36 - 43:32)

D'accord? Tu as compris le mécanisme? un accident de la circulation ou la une bagarre ou les

choses d'accord? La fréquence des traumatismes maculaire est la macula fixe Vous avez compris? En dehors de la macula et la région interpapillomaculaire c'est sans conséquence. La gravité ici c'est en plein macula ici ou la région interpapillomaculaire elle lèche parce que les fibres maculaires pour arriver au niveau de la papille et faire constituer le neuropsychiatre c'est une tragédie. En dehors de ces zones, il n'y a pas de problème.

(43:33 - 43:59)

Ils sont cassés. Ils sont dangereux. Ils sont dangereux.

Vous avez compris? C'est la rupture de la d'accord? On va l'avoir. Alors la para-clinique pour les les contusions, on peut avoir recours à l'échographie en cas de troubles de milieu. C'est l'échographie des hymènes.

(44:00 - 45:08)

Un nœud d'âme de cornée, une hyphéma, une cataracte obturante, une hémorragie, une hyalite d'accord? Tant qu'il y a la visibilité on ne fait pas de l'échographie. Radio de l'orbite, elle lèche le radio de l'orbite. On peut avoir donné une fracture de la paroi d'accord? Une angiographie rétinienne par exemple lors d'une rupture de la courbine l'électrophysiologie l'électrophysiologie c'est-à-dire PEV, l'URG, plus banale, l'indication on a les les tu l'examines, tu ne trouves pas d'explication.

(45:08 - 46:38)

À l'extrême tu dis que je suis à PL négatif, perception lumineuse négative, là on ne trouve pas l'explication. La perception lumineuse négative ça veut dire l'exception du lunaire optique. D'accord? Et il n'y a pas d'explication.

L'hémorragie du vitre elle est là avec une acuité visuelle. Découlement de rétine qui a avec une acuité visuelle. Avec une petite acuité mais avec une petite acuité elle est là.

Mais si la lumière mais mais tu trouves pas d'explication point d'interrogation le contexte on ne le sait pas. Donc elle n'est pas personne dépendante. Est-ce que qu'il y en a la physiologie, le neuropsique est fonctionnel, le cerveau est fonctionnel, oui ou non? Tant que le PEV, l'ERG il est bon, ça veut dire la personnalité vous me suivez? Elle dit une parmi les indications.

D'accord? D'autres, il y a un traumatisme ancien, très ancien ou un de une cataracte, très très ancien, je la fais, je ne la fais pas, est-ce qu'il va récupérer, est-ce qu'il va pas récupérer? physiologique. Une fonctionnalité, on peut s'aventurer. l'électrophysiologie elle est atteinte, pourquoi le faire? Ouais, il est réclame une récupération visuelle.

(46:39 - 49:18)

D'accord? L'électrophysiologie elle est atteinte ou elle est tranquille? D'accord? Parmi les indications et surtout l'électrophysiologie dans un contexte de c'est surtout médico-légal. l'experts d'accord? Mais le c'est un contexte c'est un contexte alors le traitement médical chirurgical par exemple il faut laver chirurgicalement le déplacement du cristallin mais on peut avoir à traiter chirurgicalement un déplacement du cristallin de même la déchirure rétinienne il faut la il faut laseriser une déchirure rétinienne parce que le risque ouais le décollement de rétine dans le traitement est chirurgical parce que je veux pas compliquer le traitement de l'électrophysiologie Alors chimique, on peut avoir des brûlures par acide. Essayez de me suivre parce que là les définitions sont différentes.

(49:20 - 49:48)

Vous n'aurez pas besoin de réviser. Qu'est-ce qu'elle entraîne une acide ? L'acide va entraîner une nécrose brutale par coagulation des protéines de surface de l'oeil. Alors avec la nécrose, il va donner un barrage, comme ça le produit brûlant le brûlant ne va plus pénétrer à l'intérieur de l'oeil donc les lésions sont maximales d'emblée et le patient quand il vient, ce que vous allez trouver est le maximum de lésions.

(49:48 - 50:17)

Donc on aura une nécrose locale et cette nécrose va donner un barrage qui va limiter la pénétration de l'agent brûlant, de l'acide. La gravité va dépendre de la concentration. Est-ce que c'est un acide qui est fort ou faible ? Est-ce qu'il est mélangé avec de l'eau ou est-ce qu'il est dilué ? Alors bien sûr les purs sont les plus nocifs ou généralement c'est connu des accidents d'usines ou industriels.

(50:20 - 50:42)

Alors les bases, les bases sont très très graves. Le mécanisme est là, c'est un mécanisme de saponification. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça veut dire qu'il y a une destruction de la membrane cellulaire, la membrane cellulaire des cellules de surface et qui va donner un cheminement pour la pénétration de la base.

(50:43 - 51:13)

Donc qu'est-ce qu'on aura ? Le processus va être continu et progressif dans les jours à venir. Alors que la nécrose est barrage pour la pénétration de l'acide, ici la pénétration se fait à travers une nécrose. La nécrose cellulaire va créer un cheminement pour la pénétration de la base et tous les jours on aura une nécrose qui est plus importante et les dégâts sont plus importants du jour au jour.

(51:14 - 51:39)

Ici on ne peut pas avoir évalué les dégâts le premier jour ou le deuxième jour après une brûlure par base. Vous voyez la différence ? D'accord, à la limite par acide on peut avoir une fiche, on peut avoir le certificat, on peut avoir l'acuité visuelle, la cicatrisation à partir du premier jour. Mais par base, il faut évaluer le patient tous les jours.

(51:40 - 52:03)

Parfois le produit jusqu'à pénétration du chambre intérieur, parfois il arrive jusqu'à l'irisée du cristallin. C'est-à-dire qu'on le prépare tous les jours et on n'a pas à l'arrêter. Vous voyez la différence ? Alors l'action reste continue pendant quelques jours.

(52:03 - 52:32)

Destruction d'un membre cellulaire, il creuse, il creuse, c'est comme le malpratique, le bas c'est le malpratique. Les complications secondaires sont très graves et ça touche vraiment tout, les paupières, la conjonctive, la sclère, la cornée, l'iris du cristallin et ça creuse, ça creuse. Ça peut donner une uvéite antérieure, un cataracte, un glaucome parce qu'il va pénétrer, l'élimination, c'est au niveau de l'ongle iridocornéen, il va détruire le trabeculon, il va détruire toute une base.

(52:33 - 53:00)

Et la sécheresse par la destruction des glandes lacrymales. Alors qu'est-ce qu'on peut avoir comme agent chimique ? Un solvant, un détergent, des produits de cuisine, de la douche, les gaz lacrymogènes aussi. Les gaz lacrymogènes, qu'est-ce qu'ils peuvent donner ? Ils peuvent donner une irritation corneo-conjonctivale maximale.

(53:01 - 53:11)

Ils stimulent les glandes lacrymales d'une façon profuse. Une irritation, une KPS qui va durer 4 heures. Un larmement profus.

(53:11 - 53:22)

Où est-ce qu'on a l'objectif des gaz lacrymogènes ? Les gaz lacrymogènes ne sont pas toxiques. Où est-ce qu'on a l'objectif ? La personne ne peut pas ouvrir son oeil. La durée de dialogue est à 4 heures.

(53:22 - 53:34)

Il est suffisant pour les manifestants de charge. Une irritation maximale, une petite KPS qui va guérir au bout de 4 heures. Un larmement profus.

(53:35 - 53:39)

Une irritation corneo-conjonctivale. La personne ne peut pas ouvrir son oeil. Mais ils ne sont pas

dangereux.

(53:39 - 53:45)

Les gaz lacrymogènes sont sauvages. Sauf qu'il y a l'explosion. Sinon la fumée de dialogue n'est pas dangereuse.

(53:46 - 53:56)

Donc ça fait une irritation corneo-conjonctivale très importante. Un larmement profus qui est très important, mais qui est rapidement réversible. Moins de 4 heures, tout le monde va bien.

(53:59 - 54:10)

Les brûlures oculaires, par contre, la bombe ne peut pas trier. La fumée de dialogue n'est pas toxique. Alors les agents physiques.

(54:10 - 54:20)

La flamme. La flamme est comme une flamme. Elle a un réflexe naturel.

(54:20 - 54:28)

C'est du liliar, ou moins, les paupières. Alors les flammes, on aura une brûlure de la face, brûlure de paupières. Mais généralement, l'oeil n'est pas touché.

(54:28 - 54:38)

Parce qu'on a un réflexe du clignement. On trouve des brûlures, on va dire les membres, le tronc, le visage. Généralement on ne trouve pas de brûlure par flamme de l'oeil.

(54:38 - 54:57)

Parce que le clignement va limiter la pénétration de la chaleur à l'intérieur de l'oeil. D'accord? Les métaux en fusion. et donc c'est des accidents industriels, extrêmement, extrêmement, extrêmement graves et ça va dépendre de chaque métal, les métaux, chaque métal et la température de fusion d'y elles.

(54:58 - 55:25)

Je vous donne quelques exemples. Si on a la température élevée, on a le fer, l'acier et l'aluminium, ça demande des températures très très élevées, des centaines de degrés. Quand on les diminue, on a le plomb, le zinc, le cuivre, c'est une température très faible, les lésions sont minimales puisque la température de fusion d'y elles est minime, les dégâts sont moindres.

(55:25 - 56:09)

Alors, qu'est-ce qu'une lésion conjonctivale ? Chez qui ? Chez les soudeurs. A qui les soudeurs ? Quand on leur dit qu'il faut mettre de l'aluminium, les soudeurs ont des problèmes de la chaleur, c'est une température, ou la projection des corps étrangers, les graines, ils ont l'habitude de les enlever eux-mêmes. Le problème des graines des corps étrangers, c'est qu'à force de les enlever, ça laisse des traces au niveau de la cornée, donc la pacification de la cornée et la néovascularisation de la corne.

(56:09 - 56:19)

Quand on a des dizaines, des vingtaines, des trentaines de corps étrangers, ils ne fonctionnent pas. Il est content de vivre comme ça. Ça donne aussi des symboles effarants.

(56:19 - 56:41)

Je parle des symboles effarants, c'est un accrolement entre la conjonctive et les bulbes vertes. Les liquides chauds sont classiques. C'est le classique, surtout dans les bébés.

(56:42 - 1:02:47)

Les brûlures électriques sont classiques. Les courants électriques sont classiques, d'électrocution. D'accord? Un courant électrique.

Le risque électrocardiaque surtout les troubles de rythme mais en normalement ça peut donner une cataracte d'électrocution. Ça peut exister. Bien sûr c'est des électrocutions alors les irradiations il y a deux sujets peuvent vous intéresser Alors alors donc donc alors alors et le réfléchit les rayons.

Vous savez ou la s'avez pas? Alors si par chance parce que c'est une brûlure par les UV ça prend quelques heures pour guérir ça veut dire le lendemain il va bien et lèche parce que c'est les ultraviolets et la neige il réfléchit les ultraviolets il faut porter des lunettes solaires la neige il faut les porter la neige il réfléchit les ultraviolets il faut faire attention hein le soleil d'altitude alors c'est du douleur très violente alors elle a elle a elle demande du temps pour euh pour se constituer donc pas ouvrir l'oeil, l'oeil est rouge, elle lèche parce que c'est une kératite superficielle liée à l'exposition du soleil C'est un alarmement profond, une photophobie c'est rien de grave le lendemain tout le monde guérit mais le conseil il faut porter des lunettes de protection des lunettes solaires c'est une kératite ponctuée superficielle la guérison en quelques jours sans éclair vous savez que ça existe et les radiations ionisantes ça c'est médecine de guerre c'est particulier soit des industriels soit les médecins militaires alors pour évaluer euh pour euh le pronostic de ces patients alors les classifications je vous expose la la première qui stratifie les patients en quatre grades qui a de très bons pronostics c'est juste une désépithélialisation de la corne ça veut dire juste l'épithélium qui est enlevé le limbe elle est correcte et le stroma elle est correcte alors deuxième aussi de bons pronostics alors ici un œdème de corne qui se constitue mais l'iris il est visible alors comment on va évaluer l'œdème de corne est-ce qu'il est important

ou pas ça veut dire l'iris on arrive à voir les détails quand on a un œdème très important l'iris et l'ischémie l'ischémie limbique c'est moins de tiers de la circonférence limbique alors ça trois les choses sont plus compliquées bien sûr on a la désépithélialisation, l'opacité qui masque les détails de l'iris et moins de la moitié du limbe est déjà ischémique, le stade quatre ça veut dire que tous les dégâts ils sont déjà là. Une classification qui est plus intéressante sinon qui est la classification de Dua et je demande surtout d'apprendre à parler de la question d'examen qui saute à chaque fois qu'on a la brûlure c'est la conduite à tenir il y a des questions qui vont vous intéresser la question il vous intéresse tout le monde qu'est-ce que vous allez faire pour lui vous êtes médecin quelqu'un vous êtes médecin à la maison est-ce que vous allez le faire Il y a des choses. C'est une conduite à tenir devant un brûlé.

Et vous allez voir. C'est un c'est un lavage abondant. Le lavage abondant c'est pas obligatoire.

Le lavage abondant. L'accident c'est le lavage, l'eau de l'eau de la robinet. J'insiste sur deux choses, c'est le ton de lavage et la quantité de lavage.

C'est très désagréable, ça veut dire un milieu médicalisé, vous allez mettre une goutte de d'anesthésie mais à défaut, faites avec les moyens de bord. C'est la quantité c'est la quantité et le temps. Mais j'insiste la question, question d'examen.

Parce que c'est comme ça que vous allez le sauver. Quand je vous dis bien la mécanique vous allez le sauver l'acide au base il faut l'éliminer de l'œil. Et surtout le mécanisme de saponification qui va creuser à l'intérieur détruire la membrane cellulaire il faut l'éliminer de l'œil, l'éliminer c'est les premières secondes, vous êtes d'accord ? Tant qu'il est là, il va creuser, la base elle est là, elle va creuser, les premiers gestes, on met les gestes qui vont sauver les patients.

(1:02:49 - 1:04:46)

Bécher, si l'hôpital fait son 1 quart d'heure, elle l'a arrêté, c'est-à-dire qu'elle n'a pas laissé Luc, vous êtes d'accord ? Mais Luc, le lieu de l'accident, où est-ce qu'il va le sauver ? Alors lavage abandon et prolongé, terrain salé, c'est un lieu, sinon l'autre mobilier, sur le lieu de l'accident, ne jamais, ne jamais faire de neutralisation, surtout la base, la base elle creuse, brûlure par acide, brûlure par base, ne jamais faire de neutralisation, ne jamais faire de PH neutre, brûler acide et de base. Ablation de corps étrangers, s'il y en a qui, qui a des brûlures par l'achat d'eau, qui a des éclats de batterie, qui a des sous-gants, par exemple, la batterie elle se brûle, elle se brûle, la batterie c'est une brûlure, ou des éclats, les éclats d'eau, qui a des corps étrangers, quand tu es sur place, il y a des corps étrangers, il y a des choses sur le visage, sur le bord, sauver ce qui est sauvable, d'accord ? Un sédatif antalgique, un comme un Doliprane, un comme un Chihaja qui peut relâcher le patient, donnez-lui, d'accord ? Et notez, le temps que si vous l'accompagnez à un centre santé ou à un hôpital, transférez le patient dans un milieu ophtalmologique et lèche, refaire le lavage. Dis-moi, vous êtes médecin, le médecin ophtalmo, mais qu'est-ce qui t'arrive ? Et lèche, parce que déjà le patient n'a pas reçu d'anesthésie, il va couper plus, donc on va

considérer que le premier lavage, il était plus ou moins pas très efficace, donc on va le faire d'une façon plus appropriée, vous êtes d'accord ? Donc l'anesthésie, on va faire un très bon lavage, deux lavages c'est mieux que l'une.

(1:04:49 - 1:05:48)

Donc refaire le lavage, placer des corps étrangers qui sont solides, faire le lavage de façon plus efficace, c'est-à-dire qu'on va refaire le lavage de façon plus efficace, et on va laver les voiles lacrymales, parce que avec le produit brûlant, il va traverser les voiles lacrymales, où est le voile d'élimination ? Il y a les larmes, il est prêt à déclarer l'acide, les voiles lacrymales, qu'est-ce que ça va donner ? Il y a les voiles lacrymales, là on va laver les voiles lacrymales, installation d'un antibiotique, un antibiotique propylacée et de la tropine pour soulager le patient. Donc, si on a des lésions qui sont bénignes, une petite antibioprophylaxie et des cicatrisants pour soulager la cornée, les lésions graves, qu'est-ce qu'on peut avoir ? Une sténose diellévois lacrymale, une opacification de la cornée, entropion ou extropion ou de l'insemlée basse. C'est les conséquences diellévoles, tu vois ? Là, c'est l'ischémé du lymphé, l'ischémé de la conjonctive et l'opacification de la corne.

(1:05:48 - 1:06:31)

Et, je ne cesse de vous le répéter, c'est la prévention qui peut sauver la patiente. Alors, j'espère que le cours d'aujourd'hui n'était pas très chargé. Alors, est-ce que vous avez des questions ? Est-ce que vous avez révisé ? Non ? Vous avez révisé ? Non ? Vous n'avez pas révisé ? Au compte de combien d'argent ? Yalla, calme-toi.

(1:06:32 - 1:07:13)

Elle n'a un patient, yalla. Vous voulez qu'on travaille ? Yalla, où est-ce que tu calmes-toi ? Un patient, un jeune, de 20 ans, lors d'un effort de martèlement. Martèlement, Shneye, martèlement.

(1:07:16 - 1:07:24)

Martèlement, Shneye. Shneye, martèlement. Shneye ? Yalla, le métraque.

(1:07:26 - 1:07:55)

Yalla, le métraque. Bricolage à la maison, métraque. Yalla, où est-ce que t'as péché ? Franc-jeu, près de la maison.

(1:07:55 - 1:10:52)

Franlle, bien-parlé les enfants ! Franc-jeu de qui ? Comment tu cours à la maison ? Qu'est-ce que t'as péré ? D'accord, c'esté les segments de notre journal . Véritablement, tout le monde uniquement. je vais te dire que elle était lors d'un martèlement, elle accuse d'une une douleur.

Toi tu vas lui dire euh tu vas lui faire un avance.

C'est ça? Tu vas lui faire un avance. Alors, il y a un avance plus ablation d'un corps étranger, des corps étrangers qui y en a. Alors euh, tu es d'accord, tu n'es pas d'accord, tu peux compléter. Il arrête à ton pas de discussion bilatérale, on va discuter.

Et on peut examiner les on a pas besoin de violence par contre. Euh, examiner l'oeil, c'est pas ça. Comment se trouve l'examen de l'oeil? Est-ce qu'on peut qu'est-ce que tu peux l'interroger Alors qu'est-ce que tu peux lui demander en train de martyler qu'est-ce que tu peux lui demander? Qu'est-ce que tu peux lui demander? Qu'est-ce que tu peux lui demander? Qu'est-ce qu'il ressent? Qu'est-ce qu'on peut chercher à l'interroger? Je change bien.

(1:11:04 - 1:21:44)

qui vont déranger le patient douleur d'accord? douleur généralement. Vous êtes d'accord ou pas? Donc ça change c'est vrai c'est vrai c'est vrai non? Alors en pratique la vraie elle aura un brouillard mais il va exprimer une expression un changement de son activité quand même quelqu'un qui a une projection de quelque chose sur son mur il n'aura pas c'est vrai soit alors on va demander alors la douleur est-ce que tu peux lui demander pour la douleur c'est important de décrire aussi de lui demander est-ce que tu peux ouvrir son mur tu m'as dit tout à l'heure que tu veux lui faire le lavage je sais pour le mettre en confiance je sais que tu souffres je sais que c'est extrêmement vigoureux il va bien une confiance oui alors je sais alors examinez-le non c'est vrai non qu'est-ce qu'on peut chercher la porche on peut chercher on va voir des bananes chercher un corréfondé sur la corne une projection on va voir un corréfondé c'est ça il est quand même on peut tenter de l'OTR de inconsensus mais sinon qu'est-ce qu'on peut chercher ça vous dérange pas de chercher un corréfondé c'est comme une chambre profonde ça veut dire quoi? le corréfondé mais c'est quelqu'un de incorréfondé la confiance il est il est c'est quoi? c'est une chambre c'est un brejet c'est pas une porche normale une voiture il est incroyable c'est incroyable il est incroyable C'est bon. Oui, c'est juste ça, là, marrons-maintenant hein c'est pas en pleine épaisseur.

(1:21:48 - 1:21:55)

Alors la plie de gournée n'est pas en pleine épaisseur. Deux cas de filtre. Il est qu'un chez un enfant, il faut toujours la fermer.

(1:21:57 - 1:22:06)

D'accord? Chez l'adulte. Il est qu'un périphérique, tu la respectes. Il est qu'un central, tu évalues.

(1:22:06 - 1:22:13)

Il est un type très profond. Parfois on dit que c'est plus commode de la fermer. Parfois.

(1:22:15 - 1:22:21)

Parfois tu la respectes. Et là je pense que la plie, elle peut créer un astigmatisme. Mais chez l'enfant, on ne discute jamais.

(1:22:22 - 1:22:31)

Il faut la fermer. Chez l'adulte périphérique, tu la laisses tranquille. Chez l'adulte ou central, tu es tout content.

(1:22:33 - 1:23:05)

D'accord? J'ai répondu? Oui? Oui, ça veut dire projection, un produit qui n'est pas chimique. Tu laves et tu donnes un antibiotique pour l'infection. C'est ça? Toujours on donne un antibiotique.

(1:23:09 - 1:23:18)

L'antibiotérapie parvo-générale ne pénètre pas l'oeil. L'antibiotique parvo-générale est utile pour les enfants. Pour les doigts d'accumulation.

(1:23:19 - 1:23:23)

Pour les nids. Pour l'étanchéité. Pour l'énorme qualité de l'oeil.

(1:23:23 - 1:23:38)

L'antibiotique parvo-générale est utile pour l'enfant. On donne un antibiotique parvo-générale pour l'enfant. Soit pour, dans le cas d'une plie, de manière à l'antibiotique parvo-générale, on la laisse dans le cas d'une plie, en donnant l'antibiotique parvo-générale.

(1:23:41 - 1:23:49)

Parce que souvent quand il y a une plie, on ne voit pas le niveau d'intimidation qu'il y a sur l'antibiotique parvo-générale. Parce que l'oeil est ouvert. Il n'est pas ouvert.

(1:23:49 - 1:23:53)

Il est ouvert. C'est à dire que les gouttes de la corona est ouverte dans l'intérieur. Cela va pénétrer dans l'intérieur de l'oeil directement.

(1:23:54 - 1:24:01)

Ce n'est pas un produit qui est destiné de rentrer à l'intérieur. C'est un produit qui doit rester à la surface. Et lui, en somme, il a besoin de l'oeil.

(1:24:02 - 1:24:11)

Cobrax pour l'oeil, qui le met à la surface de l'oeil. Et lui, en somme, il a besoin de l'oeil. Ce n'est pas un produit qui est destiné à pénétrer, à l'injecter à l'intérieur de l'oeil.

(1:24:12 - 1:34:48)

Tu es d'accord ? de l'initiative de l'initiative Alors qu'est-ce qu'il y a pour l'initiative de l'initiative de l'initiative de l'initiative générale une fois l'appel est fermé pas pour l'état, mais j'ai cette institution qui me permet soit pour l'éco-situation, soit pour l'initiative de l'initiative que ce soit local ou général local c'est un local, donc maintenant moi j'ai une injection incroyable et puis tu fais une injection thérapeutique injecte de l'initiative de l'initiative de l'initiative dédiée à l'injection une inflammation thérapeutique injecte de l'éco-initiative de l'initiative de l'initiative que tu veux le mettre, tu le mets qu'est-ce qui est anti-bispoire bispoire bois général, rien ne rend tout ce qui est anti-bispoire bois général c'est pour les années pour les premiers, pour les mois d'affirmat pour les années l'asthlière elle est bien vraiment j'ai répondu l'ananas vous voyez tout ça c'est complètement ce qu'il me conseille c'est des fruits d'autres il y a Alors si vous avez, si vous n'avez pas de questions Est-ce que vous avez des questions Vous avez des questions Vous savez Vous avez vu les questions Vous les avez C'est l'objectif de vous piéger. On a des questions Essayez, essayez. Toutes les questions C'est bon Laissez-les passer Je pense qu'on a fait C'est bon Au sujet de la vente des produits, on a des produits qui vont être disponibles en Météo, notamment un produit de chaleur, le chaleur l'a dit, le chaleur qui est très puissant, c'est-à-dire le chaleur qui est très puissant, c'est-à-dire que le chaleur est très puissante, la puissance des produits de chaleur, c'est-à-dire que les produits de chaleur sont très puissants,